Diskussion 869

Datum: 1940-05-22
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 3
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Gustav Björkman (Högerpartiet, man)

Herr talman! Då jag nu är den förste, som får yttra sig i detta ärende, må det tillåtas mig att till en början i korthet ange innebörden i utskottets utlåtande i anledning av den kungl. propositionen.

Utgångspunkten är ju, att den under senare år genomförda utvidgningen av landstingens uppgifter för såväl hälsovård som sjukvård med nödvändighet framkallat krav på en enhetlig ledning av landstingens verksamhet på dessa områden. En centralisering av denna verksamhet har redan nu i stor utsträckning i praktiken genomförts, och de i propositionen framlagda förslagen innebära ett fullföljande och befästande av denna utvecklingslinje. De grundläggande föreskrifterna angående det centrala organ, som skall utöva ledningen av landstingens hälsooch sjukvårdande verksamhet, ha införts i landstingslagen. Nämnda ledning skall, i den mån icke genom lag eller författning annorlunda föreskrives, enligt landstingets bestämmande utövas av en gemensam hälsooch sjukvårdsberedning eller ock av en särskild hälsovårdsoch en särskild sjukvårdsberedning. Sjukvårdsberedning kan vara direktionen för ett eller flera sjukhus. Beredning kan vara förvaltningsutskottet eller del därav.

Den föreslagna organisationen ger sålunda utrymme för en smidig anpassning efter de skiftande behoven på olika orter i landet. De lagar, som det nu är fråga om, äro, utom landstingslagen, som jag nyss nämnt, en sjukhuslag, och så är det vissa ändringar i lagen om distriktsbarnmorskeväsendet och epidemilagen. Vidare har departementschefen på skilda ställen i propositionen

Utskottet har nu i stort sett — jag kan säga, nästan alldeles — följt den kungl. propositionen, men utskottet har ansett, att ikraftträdandet bör för ett år uppskjutas. Utskottet har nämligen icke tänkt sig möjligheten av den kungl. propositionens ikraftträdande förrän den 1 januari 1942. Det är vissa omständigheter, som ha gjort, att man finner, att vederbörande landsting, särskilt i dessa tider, kunna behöva ökad tid och ökad möjlighet att anpassa sig efter de nya anordningarna. Sedan tillkommer en liten fråga; utskottet har ansett. att möjlighet skulle finnas för sjukstuga med högre sängantal än 30 att under särskilda omständigheter få underläkare.

Efter dessa få ord om innebörden i den kungl. propositionen, till vilken utskottet ju i huvudsak anslutit sig, ber jag kammarens ledamöter bemärka att ändock några reservationer äro

fogade till utskottets utlåtande. Jag skall försöka i korthet anföra grunden till de reservationer, under vilka mitt namn står. Dessa tre reservationer stå egentligen i nära samband med varandra, och kammarens ledamöter behöva därför icke frukta, att det skall uppstå alltför stor splittring vid handläggning av ärendet. Reservationerna, som jag vill tala för, gälla tillsättning av underläkare vid sjukhus och den därmed direkt förenade lilla detaljen angående tillsättning av distriktstandläkare, samt vidare utfärdandet av instruktioner för lasarettsläkare, underläkare och husmoder. TI alla dessa fall gäller det frågan, huruvida myndigheten skall fråntagas medicinalstyrelsen och tilläggas sjukvårdsberedningen. Jag vill vidare framhålla, att den enligt min mening mest betydelsefulla av reservationerna, den, som berör frågan, huruvida underläkare skola tillsättas av medicinalstyrelsen eller av sjukvårdsberedningen, förutom av mig är undertecknad av **fröken²** Hesselgren samt herrar Ekströmer, Sandström och Nolin.

Nu ber jag kammarens ledamöter att i utskottsutlåtandet se på sid. 6. Av vad där står framgår att enligt gällande bestämmelser lasarettsdirektionen, efter yttrande av vederbörande lasarettsläkare, upprättar förslag och ger förord, varefter medicinalstyrelsen utfärdar förordnande. Enligt förslaget skall emeilertid sjukvårdsberedningen ge förordnande, sedan en särskild sakkunnignämnd uppgjort förslag. Därom kommer sedermera att närmare bestämmas i en sjukhusstadga. Man kan av gjorda uttalanden förstå, att denna sakkunnignämnd 1 vart och ett av de 24 landstingsområdena skall bestå av tre läkare, helst lasarettsoch sanatorieläkare. Enligt förslaget skulle vederbörande lasarettsläkare avge förord och direktionen avge yttrande, men sedermera är det sjukvårdsberedningen, denna icke direkt medicinska myndighet, som med ledning av det förefintliga materialet skall utse underläkare. Underläkare skall kunna få klaga — det är något som kommer fram enligt de sakkunnigas utredning — dock endast på materiell grund, d. v. s. om förslaget skulle anses innebära någon orättvisa, men förslaget får icke överklagas. Som vi alla veta, innebär ett sådant förslag också, att om någon i förslaget deltagande haft avvikande mening från majoriteten, är detta detsamma som om det hade varit beslut av ma- Joriteten, och då äger vederbörande att även i den delen föra klagan.

Nu har från läkarhåll en stark opposition framkommit i denna sak, närmare bestämt från medicinalstyrelsen, Sveriges läkareförbund, lasarettsläkarföreningen och Sveriges yngre läkares förening, och det är särskilt de av denna sistnämnda förening anförda synpunkterna som gjort, att vi reservanter ansett det vara betänkligt att fråntaga medicinalstyrelsen befogenheten att utfärda förordnanden. Alla dessa sammanslutningar intaga ur medicinsk synpunkt ungefär samma position. Man är särskilt rädd för att icke enhetliga grunder skola kunna tillräckligt tillgodoses, och man fruktar att det objektiva bedö-

Nu kan det ju sägas, att klagorätt finnes, men det är nog icke så orätt som en lasarettsläkare och förutvarande styresman på lasarett skriver till mig med anledning av denna fråga, att klagan göres säkert endast i sådana fall, då rätten alltför hårt blivit satt åt sidan. Det är icke så »kamratligt» att klaga, och förordnande å annat lasarett erhålles väl snart nog, och därför

skulle säkerligen vederbörande draga sig för att anföra klagomål över ett beslut, som en sjukvårdsberedning skulle fatta. Men främst har det för oss reservanter på denna punkt gällt de av yngre läkares förening framförda kraven på enhetlig praxis och säkerhet och på frihet från lokala synpunkter, som kunna göra sig gällande. Det kan hända — jag vill icke påstå, att det är något som man egentligen vill utsäga, men det kan hända, att om det sitter två lasarettsläkare i denna särskilda sakkunnignämnd och var har sin kandidat, det mycket lätt blir så, att de kunna foga sig i varandras särskilda synpunkter. Då kan det bliva sådant, som medicinalstyrelsen med nu gällande ordning icke skulle tillåta.

Vidare måste man väl, om det nu blir ett sakkunnigsystem med 24 olika nämnder, fråga sig, om det är nödvändigt att införa ett sådant nytt nämndsystem. Blir det ej omöjligt att få fram enhetliga principer bland dessa 24 särskilda sakkunnignämnder?

När jag nu stryker under att denna sak bör ligga under medicinalstyrelsen och icke under sjukvårdsberedningarna, vill jag påpeka att jag helt och hållet talar i sjukvårdens intresse. Sjukvården är ju härvidlag nummer ett, och en av de viktigaste uppgifterna på ett sjukhus är att de medicinskt sjukvårdande synpunkterna få bli avgörande vid underläkarnas tillsättande, vilket bäst kan ske om den säkraste medicinska myndigheten får ha sista ordet.

Tandstingsförbundet har visserligen påpekat att det icke har förekommit många klagomål, men — och det vill jag särskilt stryka under — landstingsförbundets styrelse slutar sin skrivelse i saken med att uttala, att den icke anser det vara något vitalt landstingsintresse, att befogenheten att förordna underläkare tillägges det centrala landstingsorganet. Det är således ingen hjärtesak för landstingsförbundet, och då bör det heller icke vara någon hjär-

Detta är egentligen vad jag har att säga, och jag vill bara tillägga att de skäl jag här har anfört även kunna tillämpas på tillsättningen av distriktstandläkare. Vid avfattandet av de nu gällande bestämmelserna förutsattes uttryckligen att tillsättningsproceduren skulle vara densamma som beträffande sjukhusunderläkarna, varför skälen måste vara desamma i det ena som i det andra fallet. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på att medicinalstyrelsen och tandläkaresammanslutningarna ha ansett att den föreslagna ändringen i tillsättningsproceduren skulle medföra risk för att de sökandes och behörighet icke bleve bedömda efter enhetliga grunder för hela andet.

Slutligen vill jag nämna några ord om departementschefens uttalande att instruktioner för sjukhusläkare och husmor skulle utfärdas av sjukvårdsberedning och icke såsom nu av medicinalstyrelsen. Här hålla medicinalstyrelsen och läkarsammanslutningarna på den centrala medicinska myndighetens auktoritet, och sjuksköterskeföreningen understryker för husmödrarnas del liknande synpunkter. Man påpekar särskilt att en instruktion, som utfärdades av en sjukvårdsberedning, skulle på underläkare kunna lägga uppgifter, som icke stå i överensstämmelse med de krav, som ur rent medicinska synpunkter ställas på honom, och framhäva vissa ekonomiska besparingssynpunkter, som icke direkt ha med sjukvården att

göra.

Det genomgående för de reservationer, jag nu talat för, är att de önska att bedömningen skall ske enhetligt och av det mest kvalificerade organet. Detta är ett rent sjukvårdsintresse och på intet sätt något underkännande av det stora, enhetliga organisationsförslaget, vilket även reservanterna i övriga avseenden givit sin glada anslutning. Jag yrkar sålunda, herr talman, bifall till de av mig m. fl. avgivna reservationerna, och kommer ytterligare att framställa detta yrkande, då den särskilda punkten om underläkarna föredrages.

2. Wilhelm Källman (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Såsom utgångspunkt vid behandlingen av den förevarande frågan vill jag, utöver vad herr vice ordföranden i sammansatta utskottet anfört, fästa uppmärksamheten på följande.

Landstingens utgifter under 1940 utgöra i avrundat tal nära 140 miljoner kronor, varav enbart för hälsooch sjukvård är avsedd en summa av 89 mil- Joner kronor. Från föregående år har kostnadsökningen för enbart landstingens sjukvård uppgått till icke mindre än 10 miljoner kronor. Att omslutningssumman är betydligt större veta alla, då ju landstingen bland sina utgifter upptaga egentligen nettokostnaderna. Landstingsskatten 1939 utgjorde i medeltal kr. 2:93 mot kr. 2:81 året förut. Det uttaxerade beloppet, som utgjorde 112 miljoner kronor, hade stigit med 12 miljoner. Genom lagstiftning och frivilliga åtaganden har verksamheten på skilda områden utvecklats hastigt, och lagstiftningen behöver anpassas därefter.

Enligt den kungl. propositionen föreligga nu flera möjligheter för sjukvårdens och hälsovårdens huvudmän att organisera sin förvaltning på dessa de viktigaste och dyrbaraste områdena, och de olika alternativen finnas återgivna på sid. 3 i utskottets utlåtande. Att sjukvårdsberedningen efter direktions hörande får avge förord beträffande tillsättande av lasarettsoch sanatorieläkare, att samma beredning kommer att förordna underläkare, samt att hälsovårdsberedning bemyndigas förordna distriktstandläkare och föreståndare för centraltandpoliklinik har visserligen mött ett visst motstånd från läkarhåll, men torde innebära större objektivitet i fråga om förord samt underlätta medicinalstyrelsens arbete på områden där styrelsen tidigare nästan undantagslöst följt givna förord, varför alla formaliteter härvidlag under medicinalstyrelsens medverkan föranlett arbete och besvär utan verklig nytta. Detta gäller även i fråga om detaljer, sådana som beräknande av ålderstillägg för vissa befattningshavare.

Jag är i allt väsentligt ense med propositionens förslag och skall därför inskränka mig till att behandla blott en, men en viktig punkt, där jag har en annan mening. Det gäller styresmans och sysslomans inbördes befogenheter. Kungl. Maj:t har där frångått de sakkunnigas förslag. Tillsammans med åtta andra ledamöter av denna kammare har jag därför i motion nr 162 yrkat att riksdagen måtte ansluta sig till de sakkunnigas i detta avseende enhälliga mening. Det är märkligt att motionerna icke vunnit majoritet i utskottet. Huvudorsaken därtill torde vara utskottets välvilliga motivering, vilken emellertid tyvärr lider av det felet att vara oklar.

Utskottet erkänner att de ekonomiska ärendena, vilka sysslomännen handlägga, äro av stor vikt, och att sysslomännen därför böra erhålla en sådan ställning att de känna sitt ansvar för sjukvårdsanstalternas ekonomiska skötsel. En enhetlig ledning inom sjukhusförvaltningen måste dock beaktas, och denna skall utövas av styresmannenläkaren. Utan undanskjutande av denna synpunkt, säger utskottet slutligen, bör det vara möjligt att i framtiden liksom hittills mångenstädes skett bereda sysslomännen en förhållandevis självständig ställning.

Frågan är nu: kan styresmannen-läkaren ombesörja en sådan enhetlig ledning av den ekonomiska förvaltningen som väl alla finna önskvärd? Svaret måste bli att detta är omöjligt, vad angår de större sjukvårdsanstalterna. Att tro att läkaren skall orka med sådant, är att leva kvar i tider då ett lasarett egentligen var en mindre sjukstuga med läkare, »sjukhusdräng» och »sjukhuspiga». Det innebär också med andra ord, att man visserligen icke kan blunda för utvecklingen, varför självklart sysslomännens ställning erkännes, men att skenet av att läkaren bäst förstår även de ekonomiska problemen skall upprätthållas.

1901 års lasarettsstadga innehöll bestämmelser om läkarens överhöghet på sjukhus enligt 1860-talets regler. Dessa ändrades icke obetydligt 1928. Då tilldelades sysslomannen befogenhet att skriftligen eller muntligen yttra sig i ärende som rör lasarettets ekonomiska förvaltning. Han fick initiativoch yttranderätt hos direktionen och ägde anteckna skiljaktig mening till protokollet i ekonomiska frågor. Kvalifikationer för valbarhet fastställdes. Det var alltså stora reformer fram mot en lämplig uppdelning av arbete och ansvar. Men den »enhetliga ledningen» bibehölls hos styresmannen.

De sakkunniga vilja fullfölja en naturlig utveckling och nu lagfästa praxis. Tiden är mogen för en reform, varigenom styresmans och sysslomans arbetsuppgifter och ansvar fördelas även i lagstiftningen på ett mera lämpligt sätt. De framhålla också, att även om styresmannen rent formellt har ansvaret för jämväl den ekonomiska förvaltningen vid sjukhusen, det icke kan förnekas att det i allmänhet är sysslomannen som i första hand bevakar och får bära

En del sysslomän lära för närvarande icke ha den kompetens som föreskrives. Detta förklaras av att de utses av direktionerna, av vilka en del, såsom känt är, stundom utsett vänner och bekanta, utan hänsyn till kompetens. Sådant måste emellertid upphöra i och med att sjukvårdsberedningen kommer att utse dessa befattningshavare. Det blir då icke längre möjligt att utse en olämplig person till syssloman för att denne skall bli försörjd. Men besvär över sådant olämpligt val har som bekant icke kunnat föras, såvida icke något formellt fel begåtts vid valet. Det är beklagligt att t. o. m. ledamöter av utskottet intagit sin ställning och voterat för nu gällande ordning på grund av anförda, mera enstaka missförhållanden, utan hänsyn till den sakligt betydande ändring som sker i och med att sjukvårdsberedningen blir väljarekorporation. De borde ha observerat att små lokala försörjningssynpunkter, som hittills här och var ha haft inflytande, för framtiden få **maka³** åt sig för ett objektivt bedömande.

I tidskriften Sjukhuset nr 2 1940 förekommer ett mycket vederhäftigt uttalande i denna fråga.

Dess längd förhindrar mig att återge detsamma, men jag kommer i det följande att upptaga ett och annat av vad där framhålles.

I diskussionen om enhetlig ledning av våra sjukvårdsanstalter har förbisetts en faktor, som vi i vår reservation påmint om, nämligen direktionen. I 10 8 sjukhuslagen heter det: »Den närmaste tillsynen vid och. ansvaret för förvaltningen av sjukhus skall utövas av en direktion, vilken utses av den som driver sjukhuset.> Är detta en lag utan innehåll? Vem är det som av huvudmannens revisorer är underkastad redovisning och ansvar? TI varje fall icke styresmannen. Det är till sysslomannen revisorerna i första hand vända sig för att få förklaringar. Men finnes skäl till anmärkning eller utkrävande av ansvar, riktas sådant mot direktionen. Direktion är icke allenast ett rådgivande organ åt styresman vid dennes utövande av något slags obegrtiplig, enhetlig. personlig ledning, utan en styrelse för vederbörlig sjukvårdsanstalt. Hos direktionen skall den enhetliga ledningen av den ekonomiska förvaltningen vara förlagd. Utom av vad som säges i sjukhuslagens 10 $ bör ej förglömmas innebörden av sjukhusstadgans 8 $ i sin nuvarande och av Kungl. Maj:t föreslagna lydelse. (Bifalles vår reservation skulle givetvis denna paragraf få en klarare och mera med verkligheten överensstämmande lydelse.) Men vi kunna utgå ifrån att ingen ändring sker. Då kommer alltfort att stadgas en styresmannens plikt att till behandling förbereda och inför direktionen föredraga alla på dess prövning ankommande ärenden, som ej ordföranden förbehåller sig. Ordföranden kan sålunda ställa styresmannen helt åt sidan. Om så sker — hur går det då med »enhetlig ledning», utövad av styresman? Detta till mom. 1 av stadgans 8 $. I mom. 2 får direktionen befogenheten bestämma, att styresmannen skall rådföra sig med sysslomannen och en eller två av direktionens ledamöter. Detta är en egendomlig omskrivning för det faktiska förhållandet, att framför allt vid större sjukhus direktionen utser ett beredningsutskott, bestående i regel av ordförande, vice ordförande, styresman och syssloman, med den senare såsom sekreterare och i egentlig mening arbetande. Hur verkar då ett sådant beredningsutskott vid ett av våra större sjukhus? Jag tager några stickprov som exempel från Stockholms läns centrallasarett, vars direktion jag tillhört i många år.

Ett större sjukhus är i våra dagar ett slags samhälle med huvudsakligen gemensamt hushåll. Administrativt tillämpas ett avsevärt antal lagar och författningar. Kontakt upprätthålles med anhöriga, sjukkassor, fattigvårdsstyrelser m. fl. Anställning av personal, bostäders anordnande, semestrar,

Betydande specialkunskaper erfordras för att ombesörja alla inköp, som höra samman med kosthållet. Sysslomannen får här konferera med **kvinnlig**[1] expertis och läkare på olika avdelningar i vissa fall, men i det väsentliga själv uppgöra förslag till beredningsutskott och direktion. Beträffande kostnaderna för värme, lyse, vattenförbrukning, tvätt och renhållning samt inköp av en mängd olika slags förbrukningsartiklar är självklart sysslomannen under direktionens och dess beredningsutskotts icke blott förmanskap, utan även inseende, den ledande kraften.

Inom de byggnadskommittéer, som hos oss sammansättas av ledamöter från förvaltningsutskott och direktioner, är sysslomannen sekreterare, kassaförvaltare och praktiskt taget verkställande ledamot. Han har närmast att hålla ihop det hela, vilket i förekommande fall innebär ett stort både arbete och ansvar. Ständigt återkommande reparationsarbeten av skiftande slag, utförande av vissa arbeten med egen personal, ekonomiska utredningar, påkallade av direktion, sjukhusberedning, stundom statsorgan, ledning av ambulansverksamhet m. m. göra det fullständigt uteslutet, att styresman, som har sin läkargärning att utföra, skulle med någon verklig mening på dessa områden av förvaltningen kunna utöva inseende över sysslomannen. En styresman varken kan eller vill fullgöra en sådan uppgift, och då blir det en osanning att i lag utskriva, att han utövar den enhetliga ledningen av sjukhusets ekonomiska förvaltning.

Jag vågar ej upptaga tiden med ett vidlyftigare detaljerande av detta ämne.

Då hos oss alla äro ense om att praktisera den ordning, som de sakkunniga och vi motionärer också vilja ha legaliserad, så går det bra. Skulle emellertid en styresman vilja utnyttja sin rätt till något slags inseende i tusentalet detaljer, skulle mycken tidspillan och irritation komma att utgöra hinder i sysslomannens arbete.

Med den utveckling det svenska sjukhusvårdsväsendet numera nått och de betydande kostnader för detsamma, som åvila de skattdragande, blir det av större vikt än tidigare att den ekonomiska ledningen handhaves av för sådant ändamål utbildade personer. Staten själv synes ha haft tankarna härpå, då t. ex. för karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet förordnats särskild sjukhusdirektör. Denne är f. n. icke läkare. Samma är förhållandet i Göteborgs stad. I Stockholm är visserligen motsvarande befattningshavare läkare, men ej tjänstgörande sådan. Detta bör vara något att tänka på, när nu riksdagen skall uttala sin mening om sjukhusstadgan i denna del.

Uti det förslag till lydelse av sjukhusstadgans 8 $, som framlagts av de sakkunniga, föreslås en lämplig uppdelning av de beredningsoch föredragningsuppgifter; som framdeles skulle tillkomma styresman och syssloman. Detta har ytterligare betonats i de sakkunnigas förslag till ny lydelse av 32 $ samma stadga. Därigenom skulle sysslomannen icke ställas under styresmannen, utan, såsom naturligt och riktigt är, under direktionens både förmanskap och inseende.

Den uppfattning reservanterna på denna punkt givit uttryck åt och som jag ytterligare sökt motivera, delas i stort sett av dem, som i det praktiska arbetet ha hand om den svenska sjukvårdsförvaltningen. Svenska landstingsförbundet bör härvid vara en verkligt representativ institution. År 1936 begärde landstingets förbundsmöte en på hela denna frågas stora område mera

Med stöd av vad jag nu anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den av mig m. fl.

avgivna, till utskottets utlåtande fogade reservationen.

3. Gustav Möller (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag skall icke uppta kammarens tid med något mera utförligt inlägg beträffande det förslag som här föreligger. Jag är för min del mycket tillfredsställd med utskottsbehandlingen, och tillåter mig nu så att säga i klump uttala den förhoppningen att utskottets förslag måtte antagas av kammaren.

I fråga om reservationerna skall jag endast uppehålla mig. vid den av herrar Källman m. fl. avgivna. Jag vet mycket väl att man på landstingshåll har drivit den meningen att chefsskapet på ett sjukhus skulle ordentligt delas upp mellan läkare och syssloman. Jag kan försäkra att jag i princip delar den meningen att detta bör ske. Att Jag inte har vågat föreslå det, beror helt enkelt på att jag inte har kunnat få en konkret föreställning om var gränsen mellan de två kompetensområdena skulle gå. Det vore enligt min uppfattning en olägenhet om de nya linjerna ledde till att en mer eller mindre allvarlig kompetenskonflikt uppstod mellan sysslomannen och styresmannen. Jag har försökt få klarhet i denna sak genom samtal med landstingsmän och andra som varit anhängare av en sådan »rationell klyvning» av befälsskapet. Jag har till exempel ställt frågan: Vart skall en husmor höra? Skall **hon²** till hälften höra under sysslomannen och till hälften under läkaren? Men jag har inte kunnat få något bestämt svar från anhängarna av den mening som herr Källman och de sakkunniga företräda.

Jag skall beröra ett annat spörsmål. Det är ju uppenbart att kosthållet på ett lasarett är en av de ekonomiskt allra mest betydelsefulla frågorna. Med en sträng uppdelning av arbetsuppgifterna är det naturligt att denna fråga hänföres till sysslomannens område. Nu vet man emellertid att den rent medicinska utvecklingen går i den riktningen att större och större vikt lägges på näringsfysiologiska faktorer, och därmed kommer man genast in på den speciella sakkunskap som lasarettsläkaren kan väntas besitta. Om det blir en konflikt mellan å ena sidan vissa medicinska synpunkter och å andra sidan de ekonomiska synpunkter som sysslomannen har att företräda, undrar man vem som skall bli den slutligt avgörande, även om den aktuella tvisten hänskjutes till direktionen. Om man noggrant går igenom dessa spörsmål, tror Jag man kommer att stöta på åtskilliga detaljer, där det inte utan vidare är givet vem som efter en rationell klyvning skall omhänderha dem, om det skall vara sysslomannen eller om det skall vara styresmannen. Det är med

Däremot är det för mig alldeles självklart att det finns en serie frågor där sysslomannen naturligtvis bör vara föredragande i direktionen, därför att han äger en sakkunskap som styresmannen ofta saknar. Det är naturligtvis den svaga punkten i den ställning som Kungl. Maj:t, medicinalstyrelsen och läkarna själva ha intagit i denna sak, att styresmannen på ett sjukhus, vilkens utbildning icke är av ekonomisk utan av medicinsk art, blir avgörande beträffande frågor för vilka han kanske saknar intresse. Å andra sidan tycker Jag, att riskerna i detta avseende med hänsyn till direktionens därvaro inte kunna vara så stora som riskerna av en dualism i chefsskapet för ett lasarett. Jag tycker att den senare risken är större än risken

av att styresmannen skulle brista i ekonomisk kompetens. I sådana fall för övrigt, där det finns en skicklig syssloman och en läkare som vet med sig att detta inte är hans område, är jag övertygad om att det i praktiken kommer att ske den uppdelning av arbetsuppgifter som lasarettens riktiga skötsel kräver. I själva verket styrkes jag i denna uppfattning av den utveckling som har ägt rum, och som åberopas av reservanterna till förmån för yrkandet på formella bestämmelser i denna punkt. Men om man konstaterar att så är förhållandet, att man alltså befinner sig i en utveckling som alla tycka är bra, förstår jag inte att man nödvändigt skall binda utvecklingen med en stadga, om man har anledning att frukta att denna kommer att bli för schematisk på vissa punkter 1 den praktiska tillämpningen.

Det är som sagt dessa skäl som ha gjort att jag i denna punkt inte har ansett mig kunna följa de sakkunnigas förslag. Annars ha de praktiskt taget blivit följda överallt, men jag konstaterar med tillfredsställelse att även utskottsmajoriteten har hesiterat att gå på den linje som de sakkunniga och reservanterna ha förordat. Jag tror att kammaren gör klokt i att följa Kungl.